

Số: 62 /QĐ-BVPS

Cần Thơ, ngày 18 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “Quy trình Kích thích buồng trứng và theo dõi nang noãn thụ tinh trong ống nghiệm” của khoa Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Phụ sản

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Quyết định số 2599/QĐ-SYT ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học công nghệ Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Quy định số 2605/QĐ-SYT ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Sở Y tế về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Biên bản họp ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Khoa học công nghệ Bệnh viện Phụ sản về việc thông qua “Quy trình Kích thích buồng trứng và theo dõi nang noãn thụ tinh trong ống nghiệm”;

Xét đề nghị của Hội đồng Khoa học công nghệ Bệnh viện Phụ sản;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Phụ sản,

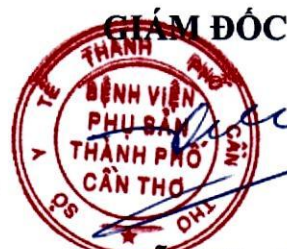
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này “Quy trình Kích thích buồng trứng và theo dõi nang noãn thụ tinh trong ống nghiệm” của khoa Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng các khoa, phòng, viên chức, người lao động tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, KHTH, TCCB.



Nguyễn Hữu Dự

BẢN GỐC**QUY TRÌNH ĐANG HIỆU LỰC**

Quy trình kích thích buồng trứng và theo dõi nang noãn TTTON

Mã tài liệu: CM-HM-22



BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHOA HỖ TRỢ SINH SẢN

Mã tài liệu CM-HM-22

Phiên bản 5.0

**QUY TRÌNH KÍCH THÍCH BUỒNG TRỨNG
VÀ THEO DÕI NANG NOÃN
THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM**

Ngày hiệu lực 18.01.2021

Số trang 07

	Họ tên	Chức vụ	Ký tên	Ngày
Biên soạn	BS. NGUYỄN THỊ THANH NGÂN	Nhân viên		22.../12.../2020
Biên soạn	CNĐDPS. TRẦN THỊ OANH	Nhân viên		22.../12.../2020
Biên soạn	NHS.PHAN THỊ KIM LIÊNG	Nhân viên		22.../12.../2020
Xem xét	THS. BS. NGUYỄN PHAN VINH	Phó Trưởng khoa		06/01/2021
Phê duyệt	BS. CKII. NGUYỄN HỮU DỰ	Giám đốc		12/01/2021

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Số phiên bản	Vị trí sửa đổi	Nội dung sửa đổi	Ngày sửa đổi	Người sửa đổi

Tài liệu nội bộ

1. Mục đích

Quy trình này được lập ra để thống nhất và chuẩn hóa các bước trong theo dõi nang noãn, đối với khách hàng điều trị thụ tinh trong ống nghiệm tại khoa.

2. Phạm vi áp dụng

Quy trình này được áp dụng cho tất cả Bác sĩ, Hộ sinh khoa Hỗ trợ sinh sản trong theo dõi nang noãn cho khách hàng Thụ tinh trong ống nghiệm.

3. Trách nhiệm

- Bác sĩ chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy trình.
- Phụ trách quản lý chất lượng khoa có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn và giám sát thực hiện quy trình.
- Lãnh đạo khoa có trách nhiệm quản lý chung về tài liệu.

4. Định nghĩa và chữ viết tắt

4.1. Định nghĩa

- Kích thích buồng trứng là việc sử dụng thuốc kích thích buồng trứng theo phác đồ để tạo sự phát triển nang noãn tối ưu, gia tăng cơ hội có thai cho một chu kỳ điều trị bằng phương pháp Thụ tinh trong ống nghiệm.
- Theo dõi nang noãn trong thụ tinh trong ống nghiệm bao gồm siêu âm nang noãn và xét nghiệm nội tiết (Estradiol, FSH, Progesterone) vào từng thời điểm tùy thuộc theo sự phát triển của nang noãn.

4.2. Chữ viết tắt

AFC	Antral follicle count – Số nang noãn thứ cấp đầu chu kỳ
AMH	Anti-muller hormone
BS	Bác sĩ
E2	Estradiol
HS	Hộ sinh
GnRH antagonist	Phác đồ đối vận
KH	Khách hàng (Người vợ của cặp vợ chồng hiếm muộn hoặc phụ nữ sống độc thân có nhu cầu TTTON)
KTBT	Kích thích buồng trứng
OHSS	Quá kích buồng trứng
P4	Progesterone
TDD	Tiêm dưới da

TDNN	Theo dõi nang noãn
TTTON	Thụ tinh trong ống nghiệm

5. Nội dung

5.1 Nguyên lý

KTBT trong TTTON sử dụng các thuốc tác động lên trục hạ đồi - tuyến yên - buồng trứng để:

- Tăng chiều mộ nang noãn.
- Vượt qua giai đoạn chọn lọc và vượt trội nang noãn.
- Giảm thoái hóa nang noãn.
- Phòng ngừa đỉnh LH sớm và hoàng thể hóa sớm làm mất chất lượng nang noãn.

5.2 Kiểm tra chất lượng

Đảm bảo tuân thủ quy trình thông qua việc thực hiện bảng kiểm (phụ lục)

5.3. An toàn

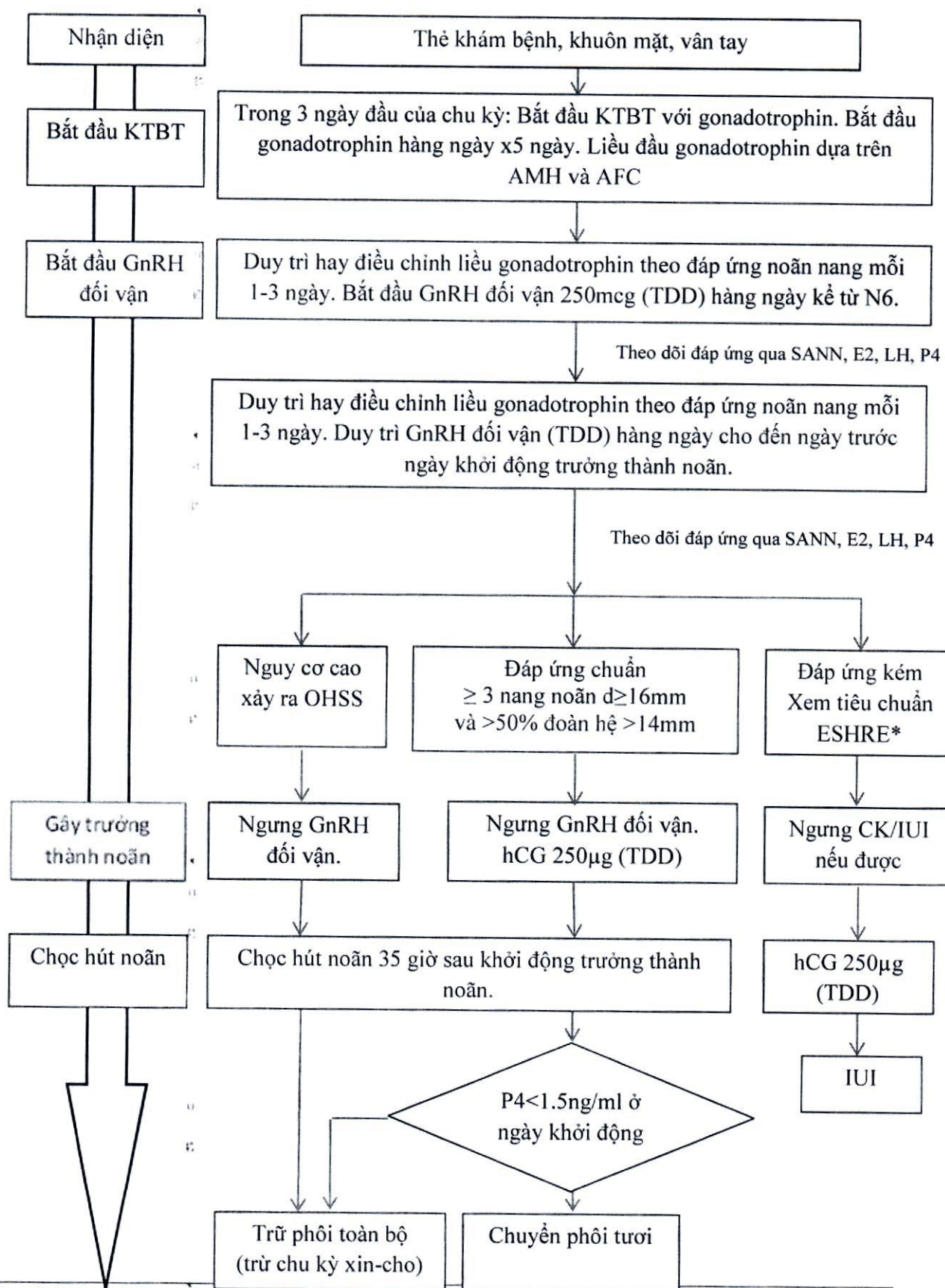
- Theo dõi triệu chứng Quá kích buồng trứng (nếu có)
- Tác dụng phụ khi sử dụng thuốc KTBT

5.4 Các bước thực hiện

Trách nhiệm	Các bước thực hiện	Mô tả và biểu mẫu
NHS	Bước 1: Nhận diện	Yêu cầu xuất trình Thẻ khám bệnh, nhận diện khuôn mặt, dấu vân tay.
BS NHS	Bước 2: Bắt đầu KTBT	Trong 3 ngày đầu của chu kỳ: Bắt đầu KTBT với gonadotrophin. Bắt đầu gonadotrophin hàng ngày x5 ngày. Liều đầu gonadotrophin dựa trên AMH và AFC.
BS NHS	Bước 3: Bắt đầu GnRH đối vận	-Duy trì hay điều chỉnh liều gonadotrophin theo đáp ứng noãn nang mỗi 1-3 ngày. Bắt đầu GnRH đối vận 250mcg (TDD) hàng ngày kể từ N6. -Duy trì hay điều chỉnh liều gonadotrophin theo đáp ứng noãn nang mỗi 1-3 ngày. Duy trì GnRH đối vận (TDD) hàng ngày cho đến ngày trước ngày khởi động trưởng thành noãn.
BS NHS	Bước 4: Gây trưởng thành noãn	-Ngưng GnRH đối vận -Chọn thuốc gây trưởng thành noãn đúng + Nguy cơ cao OHSS: Ngưng GnRH đối vận.

		GnRH 0,2 mg (TDD). + Đáp ứng chuẩn: Ngưng GnRH đối vận hCG 250mcg (TDD) + Đáp ứng kém: Ngưng chu kì hoặc IUI nếu được.
BS NHS	Bước 5: Chọc hút noãn	Chọc hút noãn 35 giờ sau trưởng thành noãn.
BS NHS	Bước 6: Chuyển phôi tươi (nếu có)	- $P4 > 1,5$ ng/ml hoặc nguy cơ cao OHSS: Chuyển phôi trữ - $P4 < 1,5$ ng/ml: Chuyển phôi tươi

6. Lưu đồ



7. Lưu trữ hồ sơ

- Quy trình được lưu trữ vĩnh viễn theo Thông tư 53/2017/TT-BYT, ban hành ngày 29/12/2017: Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành y tế.
- Hồ sơ được lưu 20 năm theo Thông tư 57/2015/TT-BYT ngày 30/12/2015: Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2015 của chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

8. Tài liệu liên quan:

Quy trình nhận diện người bệnh

9. Tài liệu tham khảo

- Phác đồ điều trị 2020 – Bệnh viện phụ sản thành phố Cần Thơ, “Phác đồ kích thích buồng trứng”, tr.6-10.
- Bệnh viện Hùng Vương (2014), Hướng dẫn Phác đồ Antagonist.

10. Phụ lục

Bảng kiểm quy trình kích thích buồng trứng và theo dõi nang noãn

Phụ lục

	KHOA HỖ TRỢ SINH SẢN	Mã tài liệu: CM-HM 22
	BẢNG KIỂM QUY TRÌNH KÍCH THÍCH BUỒNG TRỨNG VÀ THEO DÕI NANG NOÃN THỤ TINH TRONG ỒNG NGHIỆM	Phiên bản: 5.0
		Ngày hiệu lực: 18.01.2021
		Số trang: 01

Họ và tên vợ: Năm sinh:

Họ và tên chồng: Năm sinh:

Ngày thực hiện:

Người thực hiện:

Người kiểm tra:

(C: Có; K: Không)

STT	NỘI DUNG	C	K
1	Nhận diện KH		
2	Trong 3 ngày đầu của chu kỳ: Bắt đầu KTBT với gonadotrophin. Bắt đầu gonadotrophin hàng ngày x5 ngày. Liều đầu gonadotrophin dựa trên AMH và AFC.		
3	Theo dõi đáp ứng qua SANN, E2, LH, P4.		
4	Duy trì hay điều chỉnh liều gonadotrophin theo đáp ứng noãn nang mỗi 1-3 ngày. Bắt đầu GnRH đối vận 250mcg (TDD) hàng ngày kể từ N6.		
5	Duy trì hay điều chỉnh liều gonadotrophin theo đáp ứng noãn nang mỗi 1-3 ngày. Duy trì GnRH đối vận (TDD) hàng ngày cho đến ngày trước ngày khởi động trưởng thành noãn.		
6	Chọn thuốc gây trưởng thành noãn đúng.		
7	Chọc hút noãn 35 giờ sau trưởng thành noãn.		
8	Chuyển phôi tươi hay phôi trữ tùy từng trường hợp.		